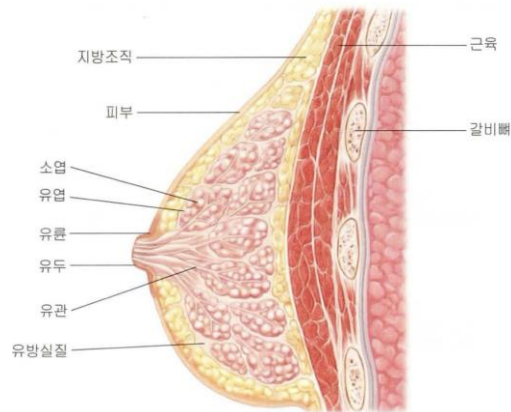


6장. 유방질환

제 1절. 유방의 해부와 생리

1. 유방의 해부

위치	전흉벽 제2늑골과 제7늑골 사이, 흉골의 외측연과 액와 중심선 사이
크기	직경 10~12cm, 두께 5~7cm
모양	둥근 모양(임신 경험x -> 타원형에 편평한 모양)
근육	- 유방의 2/3은 대흉근 밖, 1/3은 전거근에 위치 - 대흉근, 소흉근과 관
유두	- 중앙에 위치, 유륵에 의해 둘러싸임 - 이때 유륵에 있는 피지선은 여러 개의 작은 윤상돌기의 형태
구성	- 유방실질 : 유엽 → 유방소엽 → 소포 15~20개의 유엽으로 구성, 소엽단위에서 모유 생산 - 유방간질 : 지방조직, 결체조직 - 쿠퍼씨인대 : 유방의 위치를 고정, 모양 유지



※ 액와의 임파결절(교과서)

- 유방에 있어 대부분의 임파선은 액와로 배플(97%)
: 이를 이해하는 것이 진단에 도움이 됨
- 액와 중심 결절이 가장 쉽게 촉진됨
 - 1) 흉근임파결절 : 액와가 겹쳐지는 앞부분, 대흉근의 아래
 - 2) 견갑하부 임파결절 : 견갑골 측방, 액와와 겹쳐지는 후면의 깊은 곳
 - 3) 측면결절 : 상방을 따라 대개 팔 쪽을 향하여 배출

2. 유방의 생리와 연령에 따른 변화

1) Tanner 성 성숙 단계에서 정의한 유방발달의 5단계

1단계	산후기 이전, 유두만 융기
2단계	젖몽우리 단계. 작은 언덕처럼 유방과 유두 융기, 유륵 직경이 확대 되는 단계
3단계	윤곽의 분리 없이 유방과 유륵이 더 확대되고 더 융기되는 단계
4단계	유두와 유륵이 전출되어 유방의 높이 위에 제2언덕을 형성
5단계	성숙단계. 유두만 전출, 유륵은 유방의 일반적인 윤곽으로 다시 들어감

어떤 정상인에게서 유륵이 계속 제 2언덕을 형성하고 있는 경우도 있음

2) 호르몬

- E의 자극 : 유관 증대, 소엽 형성, 유선 발달 및 유륵과 유두의 착색
- P의 자극 : 배란성 월경 후 / 소엽확장과 분화 및 세엽발달 지속
- Prolactin, FSH, LH도 유방의 발달에 관여

3) 발달시기

● 월경 개시 전

- 8세 이전에 이루어진 유방발달은 조숙한 것으로 평가
- 13세에도 발달X / 유방발달 시작과 초경 사이 간격이 5년 이상
= 사춘기 지연

● 월경 개시 후

- 월경주기에 따라 주기적인 호르몬영향
- 월경진행 -> 유선관 위축
- 월경 후 -> 유선관 및 주위조직의 증식, 확장 / 유방이 커지고 단단
- 월경 후에 유방을 진찰하거나 촬영하면 다발성 결절 관찰가능

4) 임신에 따른 유방 변화

임신 2개월	- 선조직, 유관조직 증가 -> 유방 커지고 결절성 - 유두 커지고 짙게 착색되고 더 일어섬 - 유륜도 짙은 색, 유방의 정맥유형 두드러짐
16주후	- 유두에서 진하고 노란색의 초유분비 임신중반 : 유방성숙 거의 완료 임신후반 : PRL 증가 / E,P농도 감소
분만 후	- 여성 호르몬의 혈중 농도 급감, PRL 혈중농도 상승 -> 모유 분비 시작
수유 시	- 유두 자극, 유선관 주위 근상피 세포 수축작용 -> 유방 내 저류되어 있던 모유의 분출을 도움
단유	- PRL 분비 저하, 뇌하수체에서 옥시토신 분비 X -> 모유 분비 중단
폐경	- E 분비 중단 ➡ 성호르몬의 영향을 받던 유방은 퇴화하기 시작

3. 유방에 관여하는 주요 경맥, 장부, 기혈

※ 교과서 개술

- 한의학에서는 여성의 성장에 있어 유방을 중시하였음.
- 음양이론을 통해 남녀의 형태적 차이를 설명
- 유방질환의 근본적 원인으로 여성은 損肝胃 남성은 損肝腎을 제시

족양명위경	乳房屬胃 -> 유방의 기육과 유즙 생성 관련 병변은 陽明 위주 치료
족궐음간경	乳頭屬肝 ➡ 유두 병변, 유즙분비 부전 등에서 疏肝 치법 많이 활용
족소음신경	유방발달에 미치는 腎의 기능 시사
충임맥	사춘기 유방의 발달, 임신 시 유즙 분비 와 관련
기타 경맥	족태음비경, 족소양담경, 수삼음·삼양, 음·양유맥 등
기혈	기혈은 유즙의 원천

족양명위경은 유즙생성 족궐음간경은 유즙분비

제 2절. 유방의 증후와 진단

※ 교과서 개술

- 흔한 유방증상 : 유방종괴, 유방통증, 유두분비물
- > 단독으로 나타나기도 하고 복합적으로 나타나기도 함
- 증상호소 환자의 15~20%만 정밀검사 필요
- 대부분은 본인의 호소와 달리 규칙적인 자가검진만을 시행해도 무방
- 초기 유방암에 대한 특이적 증상이 없으므로 항상 세밀한 접근 요구

1. 유방의 증후

- 종괴, 통증, 비정상적인 유두분비물, 피부의 이상 소견 등으로 대별됨.
- 유방의 단일 증상은 종괴, 통증, 유두분비물의 순으로 나타남
- 유방에 종괴가 있는 경우 다른 수반증상이 있을 때 유방암 빈도가 높음 따라서, 위와 같은 경우에는 정밀검사가 요구됨.

1) 유방종괴

- 폐경 전후 여성들의 유방증상 중 가장 많음
- 본인이 우연히 종괴 발견해 병원 찾는 경우가 70% 이상
주기적인 자가검진 시행 때 종괴 발견율은 85%이상
- 유방 종괴 호소하는 여성에서 유방암 빈도 : 6.4%(매우 낮음)
다만, 질환별 특이성 없으므로 조직진단 없이 양성으로 판정 시 주의
- 40세 이전 : 축지되는 종괴의 대부분은 양성
30세 이하 : 72%는 섬유선종, 4%는 낭성병변, 3%는 섬유낭성변화, 1% 악성

※ 연령에 따른 유방진찰

- 첫 월경 시작 후 수년간 점진적인 발육을 끝낸 유방조직은 균질성을 보임
→ 유방진찰이 용이함
- 임신과 수유 및 기타 자극으로 유방조직의 변화
- 폐경기 전후의 유방조직이나 월경 중의 유방조직
→ 균질성 하락 및 결절 양상의 증가로 종괴로 오인할 수 있음

2) 유방통

- 유방질환 중 일반적으로 내과적 약물치료를 요함, 비교적 흔함
- 대부분의 유방통이 폐경 전 여성에서 나타나는 주기적 통증
- 월경 시 유방의 부종과 비후 등 유방조직의 생리적 변화를 수반 -> 확진 難
유방통증은 폐경 전 여성의 흔한 증상으로 생리적 변화에 의한 것이 대다수
- 다만, 정밀 검사 요하는 경우 : 30~50대 여성에서 종괴 축지 및 통증
- 유방암에서는 통증을 느끼는 경우가 드물(5~18%)

※ 유방암에서의 유방통의 특징적인 양상 2가지

1. 일측성으로 심하게 나타나면서 지속성 통증
2. 일부 겨드랑이나 팔로 뻗치는 통증

주기성 유방통(70%)

[정의] 월경주기와 관련하여 통증이 나타나는 것
 [연령] 30대에 발생 ~ 폐경기까지 지속 가능
 [증상]
 양측성(50% 이상), 월경주기가 되면 유방전체에 둔한 통증
 황체기부터 월경때까지 점점 심해지다가 월경 시작과 동시에 사라짐
 유방 외상방 부종, 동통, 멍울, 묵직함, 심한 동통
 [위험인자] 비만, 포화지방산 과섭취, 커피·홍차와 같은 말초 혈관 영향 음식, 약물
 [치료] 카페인·포화지방산 제한, 수면 중 스포츠브라, 타녹시펜(SERM) 6개월

비주기성 유방통

[정의] 월경주기와 관계없이 오는 통증
 [연령] 40대 후에 흔히 볼 수 있음
 [증상] 일측성, 한 부위에 국한, 심한 통증, 유방 외측상방에 결절 동반
 [대표질환] 유선관 확장증, 경화성 선종증

3) 유두분비물

- 유선관은 유방의 모든 부위의 유엽과 연결되어 있어 중요한 정보 제공
- 비수유기 여성에서 관찰되는 유두분비물은 비정상적인 소견
 다만, 이것이 바로 암을 의미하는 것은 아님
- 유두분비물은 여성에서 흔함
 └ 불편감 호소 여성의 3~10%, 양성 유발질환의 10~50%
- 유두분비물을 나타낼 수 있는 질환빈도
 └ 유두종 > 유관확장증 > 유두습진 > 파세트병 > 유방농양 > 유방암

생리적 유두분비물

[정의] 짖을 때 양측 유두 여러 개의 유선관에서 나오는 분비물
 [색상] 보통 맑거나 우윳빛
 [원인] 성적 자극, 유두 짜보는 습관, 호르몬 치료, 약물복용, 임신, 프로락틴 분비, 뇌하수체 종양, 만성신부전, 갑상선 기능 저하증

병리적 유두분비물

[정의] 유방조직이나 유선관 내에 병변이 있어서 생기는 분비물
 대부분 저절로 흘러나옴, 한쪽 유두 한개의 유선관에서 나오는 분비물
 [색상] 혈액상, 옅은 장액-혈액상 분비물, 때로는 맑은색 또는 녹회색
 [대표질환]
 붉은 색의 혈액상 유두분비물: 유선관내 유두종의 가장 흔한 증상
 30대 전후 수유하지 않는 젊은층
 만약 40대 여성에서 유방종괴 및 혈액상 유두분비물 -> 유방암 고려

유두 분비물의 특징

생리적 분비물	비자발적 분비	양측성	다수의 관에서 분비	회색, 녹색, 갈색, 우윳빛
병적 분비물	자발적 분비	일측성	1개의 관에서 분비	혈성 or 맑음

2. 유방의 진단

※ 교과서 개술

- 가장 중요한 부분은 병력조사와 이학적 검사
- 암의 위험성이 높은 환자에게는 유방촬영술, 초음파, MRI등을 사용함
- 유방암에서도 병리조직 검사가 최종적으로 필요함

1) 병력청취

- 주소증 :

: 통증, 종괴, 유두분비, 유두함몰¹, 유두습진, 유방피부이상, 액와부 종괴

- 위험인자

- ① 성별 : 가장 큰 위험인자 (여성이 남성의 100배)
- ② 연령 : 45세 이후의 모든 여성 (전체 70-80%)
- ③ 월경력 : 12세 이전의 초경 및 50세 이후의 폐경 (4~5% 증가시킴)
- ④ 임신 경험, 초산연령 및 수유 상태

: 결혼X, 늦게 결혼, 30세 이후 첫 분만, 자녀 수 많을수록, 모유수유 안할수록

⑤ 과거력

: 과거 유방암, 소엽 상피내암, 유선이형증, 난소암, 자궁내막암은 증가

: 단순 난소 절제는 감소

⑥ 비만증

⑦ 식이요인 : 고지방섭취, 알코올 섭취, 총열량 섭취의 증가, 육류의 섭취

⑧ 가족력 및 유전자 돌연변이 (BRCA1,2, P53)

2) 신체검사 : 시진, 촉진이 추가 됨

- 진단은 생리시작 후 7-10일 혹은 생리 끝난 후 3-4일 시행하는 것이 좋음
- 유두 분비를 확인하기 위해서는 유두를 짜보아야 함
- 간혹 낭종, 고형종 구별을 위해 실내 어둡게 하고 조명을 비추는 검사법 활용

시진

- ① 크기 : 양측 약간의 차이는 정상에서도 가능
- ② 대칭성 : 선천적 혹은 큰 종양으로 심한 차이가 날 수 있음
- ③ 모양 : 함몰 or 튀어나온 부위
- ④ 피부의 상태 : 발적, 부종, 궤양, 특히 굴겹질 같은 피부 → 암
- ⑤ 유두의 변화 : 1) 크기와 모양 2) 위치변화 3) 발적 및 습진성 병변

촉진

- ① 의의 : 유방검사의 기본, 가장 중요한 진찰방법
- ② 방법 : 쇄골와상부·액와부 림프절 유무 검사
팔 떨어뜨린 상태에서 촉진, 변연부 → 중심부
- ③ 확인할 것 : 종괴유무, 종괴 이동성, 경도, 피부·흉근 부착유무
종괴 입체성 유무, 압통 유무, 함몰부위, 주위와의 유착관계

※ 촉진 시 파악해야 하는 것

유방암에서 나타나는 징후	
함몰징후	- 유방암은 섬유화나 반흔조직을 형성, 섬유성 조직의 수축이 함몰징후를 나타냄 - 특히 피부압흔, 유방의 형태변화, 유두의 형태변화 포함
피부압흔	- 하부조직의 악성을 암시함
비정상적 형태	- 팔을 머리 위로 올린 자세, 앞으로 기댄 자세로 정상측과 비교
혈관계 징후	- 피부의 부종 : 임파계의 차단에 의해 발생 - 돼지 피부 굴겹질 같음 - 정맥혈관의 돌출이 뚜렷해짐

유두 및 유륜의 이상	
유두의 내변증	- 정상으로 돌출되어 있던 것이 최근에 내번되었다면 악성 병변을 강하게 의심하여야한다.
평평하거나 함몰된 유두	- 유암과 관련한 섬유화는 유두를 안쪽으로 당겨 넓어지고 평평하게 된다
유두의 편위	- 유암과 관계있는 섬유화 현상은 유두의 축을 변화 - 유암이 있는 방향으로 편위가 생김
유두와 유륜의 부종	- 임파관의 차단으로 돼지피부나 굴껍질 모양 - 이는 암을 강하게 시사함
파제트병	- 유두나 유륜에 피부염이 생기면 악성의심
유두의 분비물	- 유두의 분비물 유발요소는 대부분 악성이 아님 - 다만, 색깔에 유의하여야함
과잉 유방	- 액와나 정상유방밑에 과잉(가장 흔함) - 과잉 유방은 생조직이 거의 없음

유방결절의 감별			
병리	낭종성 질환 한 개 또는 다발성	섬유샘종 양성종양	암 악성종양
평균연령	30-55세 폐경기 후 감퇴	사춘기 청장년~55세	30-80세 중년,노년
수	한 개 또는 다발성	보통 한 개 간혹 다발성	보통 한 개
형태	원형, 부드러운 것, 단단한 것	원형, 원판형	불규칙, 성상형
경도	탄력성	단단함	단단하거나 딱딱함
경계	명확	명확	불명확
운동성	움직임	잘움직임	피하조직에 유착
압통	간혹 압통	보통 무통	보통 무통

함몰	없음	없음	자주 있음
----	----	----	-------

3) 유방의 자가검진

① 자가검진의 당위성

- 대부분의 유방질환은 본인에 의해 발견됨
- 유방 병변 발견 시 악성 소견이 없어 경과 관찰 중에도 주기적인 자가검진 필요
- 유방종괴, 유두분비물, 피부 함몰로 인한 보조개, 유두함몰, 염증성 병변 등 발견되면 즉시 진찰

② 자가검진의 최적기

- 유방의 자가검진은 매월 한 번씩 시행하는 것이 원칙
- 최적 시기는 폐경 전에는 월경 후 5일~7일 사이 (즉 난포기에 해당)
- └ 월경 직전까지 유방조직의 증식, 비대, 부종 등이 생기다가 월경을 시작하면서 가라앉기 시작해 이 시기에 부종이나 불편감이 가장 적기 때문
- 폐경 후 : 매월 1일 등 자신이 기억하기 좋은 날을 선택하여 규칙적으로 자가검진

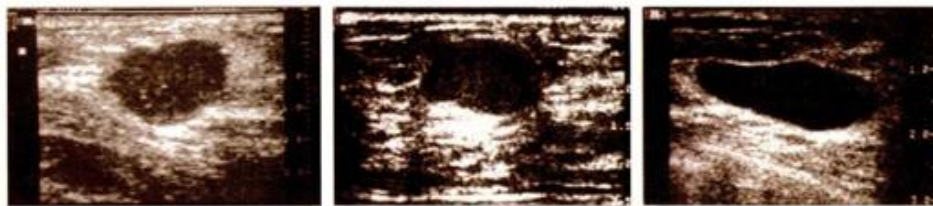
③ 유방 자가검진 방법

- 1) 샤워 중 촉진, 2) 거울 이용한 시진, 3) 누운 자세에서 촉진
- 유방암 자가검진 민감도 20~30%
- 매 월경 직후에 하도록 권장 (WHO)

4) 유방의 영상의학적 검진 및 조직검사

- 일반적으로 쉽게 선택하는 검사는 초음파
종괴위치, 형태감별 위한 1차적 비침습적 검사
- 유방 촬영술 : 정밀 진단(종괴의 크기와 모양, 피부두께 ...) 통한 유방암 확진에 필요

	경계	음영	주변조직	석회화
악성	불분명	불규칙	주변조직과 구분 잘 안됨	작고 직선형, 크기가 일정x
양성	분명	규칙적	주변조직의 변화 없음	크고, 둥글며 매끈한 윤곽



유방암

섬유선종

낭종

그림 3. 유방촬영술과 특징적 촬영 결과

※ 유방 검진 권고안(교과서)

- 30세 이후 : 매일 유방 자가 검진
- 35세 이후 : 매일 자가 검진하면서 2년 간격으로 의사에 의한 임상검진
- 40세 이후 : 매월 자가 검진하면서 1-2년 간격으로 임상진찰과 유방촬영
- 50세 이후 : 매년 시행
- 가족력이 있는 경우 30세부터 검진을 시작하거나 가족의 유방암 발병 연령보다 10세 이전에 시작

제 3절 유바으이 양성질환

1. 다유두증, 다유방증, 비대

1) 다유두증/다유방증

= 유즙선 주행로 내에 정상유두/유방 이외의 과잉으로 발생하는 것

- 비정상 유두 : 정상 유두의 5-6cm 하방에 생김
- 비정상 유방 : 정상유방이 아닌 나머지 위치
└ 액와-치골상연 연결선 중 4번째의 1쌍이 발달

2) 유방의 비대

조숙비대(=유아비대)	난소의 내분비장애로 생겨 대칭적으로 나타나는 것이 특징
처녀비대(=임신비대, 유관비대)	섬유기질 증가에 기인

2. 비수유기의 유선염과 양성종양

1) 염증성질환

결핵형질 세포성 유선염	특징적인 무통성 종괴의 파열로 인한 농의 배출 림프절을 통한 역행성 감염
외상성 지방괴사	고령인 거대유방의 환자에서 잘 생김 타박 후 무통성의 지방조직 덩어리 발생, 간헐적 피하출혈
만성 낭종성 유선염	부적절 PG 분비, E 과다, E·P 불균형로 인함 · 낭종 : 베는 듯한 통증, 장액성 분비물 · 샘종 : 30-40대에 호발, 양측성, 압통 및 갈색빛 유두 분비물
유방 농양	유선염에 병발 발생부위에 따라 유륜하 농양 · 말초성 농양으로 구분
말초성 농양	당뇨병, 스테로이드 사용, 면역력 감소 상태에서 빈발
유륜하 농양	재발률 높고 치료 어려움

※ 한의학에서의 유방의 염증성 병변(교과서)

吹乳(취유), 妬乳(투유), 乳癰(유옹¹), 乳疽(유저), 乳發(유발), 乳癰(유로) ...

- 잘감별하여 치료해야 한다.

특히 유옹은 유방의 홍종열통, 전신 오한발열을 수반하는 유선조직의 화농성 질환으로 발병시기, 원인에 따라 내취유옹, 외취유옹, 비수유기 유옹으로 분류

- 비수유기 유옹 : 가미지패산가감
- 지패산을 유옹, 유방질환에 기본적으로 고려한다

2) 양성종양

양성섬유선종	가장 흔한 에스트로겐 의존성 양성종양 20~29세 호발, 서서히 크기 증가. 결절형
관내 유두종	유두모양의 구조물이 관내로 증식한 것 배출관에선 단일성 / 말단 젖샘 소엽에선 다발성
낭종내 유두종	폐경기 전후 호발하는 양성종양 [증상] 혈성분비물, 압통 및 가동성의 종괴로 크기가 크거나 혈성 분비물이 있으면 약 10%에서 악성 변화
경화샘종	변형이 생길 수 있어 침윤성 암과 감별해야 함
거대유방점액종	폐경기에 호발하는 크기가 크고 움직이는 낭종형태 대부분 양성종양, 수년 후 육종성 변화 가능
유방육종	45~55세에 호발하는 섬유방추세포 형태의 양성 종양 급속히 거대하게 성장, 견고한 특징, 피부궤양
지방종	고령에 잘 생김, 물렁하고 통증이 없음

제 4절. 유방암

1. 개술

정의	유관이나 유엽에서 발생하는 암
역학	17,18,19년 모두 한국여성 암 중 발생빈도 1위 미국여성에서 가장 흔하게 발생하는 암
발생연령	4~50대, 최소나이 16세, 최고연령 99세 40 > 50 > 60 > 30 > 70대순
예후 예측 인자	암의 크기, 림프절 전이, 조직학적 분류, 조직학적 등급, 면역조직 표지자

유방암의 위험인자	
중요인자	경미한 인자
- 성 : 여성 > 남성 (100배) - 연령 : 45세 이상 - 가족력 : 3배 - 반대측 유방암 - 비침습적 암종 - 이형성을 수반한 양성 증식성 변화	- 에스트로겐에 긴 노출시간 └ 빠른 초경(12세 이전), 늦은 폐경(50세 이후), 늦은 초산 - 모유수유, 자녀수 많은 경우 ↓ - 음식 : 과도한 영양, 지방섭취 및 음주 - 비만 : 가슴부위비만형 > 하체비만형 - 대사증후군 - 여성호르몬제의 5년 이상 사용 - 장기간 피임약 복용 - 저용량 방사선 조사

2. 분류

1) 병리 조직학적 분류

- 발생부위에 따라 ① 유관, 소엽 등의 실질 조직에 생기는 암 ② 간질조직에서 생기는 암으로 구분한다.
- ① 유관, 소엽 발생암(=실질조직암)은 침윤 정도에 따라 침윤성 / 비침윤성암으로 구분한다.

<침윤성 유방암>

침윤성 관암종	- 유방 기저막을 침범한 암으로 유방암 중 가장 많은 빈도 (65~80%, 평균연령 47세) - 단단하고 경계가 불명확한 멍울로 나타나며, 주위조직과 유착 - 피부나 유두의 함몰, 유두의 혈성 분비물을 호소 - 원격전이 있는 경우가 가장 예후 안 좋음
침윤성 소엽암종	- 침윤성 유방암 중 2번째로 흔함 - 전체의 5-15%, 대부분 40대 - 침윤성 유관암과 예후에는 큰 차이가 없음 - 경계 불명확 멍울, 유두분비물/파제트병 볼 수 없음
유방 관상암종	- 관암종의 분화가 잘 된 변형종 - 전체의 1-2%, 평균 40대 중후반 - 다른 유방암보다 젊은 나이에 발생률 높음 - 대부분 통증 없고 1cm 내외 작은 크기, 선별검사 시행 - 유방촬영술에서 발견
수질암종	- 전체의 5-6%, 상대적으로 젊은 나이에 발생 - 꽤 큰 크기, 섬유선종으로 오인할 수 있음
점액암종	- 점액을 포함하는 종양, 침윤성 유방암의 1-7%인 비교적 드문 종양 - 고령에서 잘 발생, 예후

염증성 유방암 (전격성)

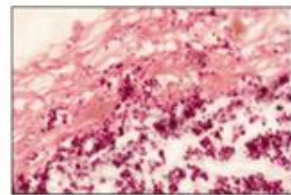
- 유방의 피부까지도 포함, 전체의 1-3%
- 피부가 두껍고 빨개지면서 굴껍질처럼 변함.
- 예후는 불량, 치료는 반드시 복합요법 사용

<비침윤성 유방암 - 상피내암>

관상피내암 DCIS	- 유방의 기저막을 침범하지 않은 것, 0기 암 - 침윤성보다 예후가 좋지만, 암세포가 기저막 뚫고 성장할 경우 침윤성 유관암으로 진행가능
소엽상피 내암 LCIS	- 소엽의 기저막을 침범하지 않은 것, 0기 암 └ 드물지만 젊은 연령에게 흔함 - 다발성, 양측성의 빈도가 높음
파제트병	- 유관에 암이 생겨 유두 및 유륜의 피부에 퍼진 유방암의 특수한 형태 └ 전체의 1-2%로 드문 암 - 상피내암 뿐 아니라 침윤성 암종과도 관련 - 유두와 유륜의 피부가 각질이 생겨 벗겨지며 빨갱게 변하여 만성습진으로 오인할 수 있음



관상피내암-0기



침윤성

그림 4. 유방암의 조직학적 소견

2) 병기

- 종괴의 크기, 주변 림프절 전이, 다른 장기에 침범한 정도를 기준으로 4가지로 분류
- 주로 AJCC/TMN 시스템을 사용함

유방암의 TNM 병기		
T병기(종괴의 크기)	N병기 (림프절 전이 정도)	M병기 (타장기 침범 여부)
Tx 종양 평가X T0 종양 증거X Tis 상피내암 T1 종양 ≤2cm T2 종양 2-5cm T3 종양 ≥5cm T4 흉벽 or 피부 침투	Nx 림프절 전이 평가X N0 림프절 전이X N1 전이된 림프절 1-3개 N2 전이된 림프절 4-9개 N3 전이된 림프절 10개 이상	Mx 원격전이 평가X M0 원격전이X M1 원격전이O

3. 치료

1) 수술요법

- 소괴절제술, 부분 유방절제술, 유방보존술

*유방보존술 : 유방크기가 적당, 젊은 여성이 종양이 1개, 2~3cm 이하일 때 유방을 보존하면서 종양, 액와 림프절, 약간의 주변정상조직을 제거

유방보존술의 절대적 금기증
① 한쪽 가슴에 한 개 이상의 병변 ② 비교적 작은 가슴 크기에 큰 종양이 발생한 경우 ③ 유방이나 흉벽에 방사선 요법을 받은 과거력이 있는 환자 ④ 방사선 치료를 원하지 않는 경우 ⑤ 임신 1기 또는 2기 ⑥ 악성 혹은 악성이 의심되는 미만성 석회화 병변 ⑦ 생검결과 절제연이 양성인 경우

2) 수술요법 외

방사선 요법, 화학요법, 표적치료, 호르몬 요법 등...

4. 유방암과 乳巖(유암)

<유방암의 한의학적 변증>

원인	칠정상 ➡ 혈기고고(血氣枯槁), 정기부족, 기혈손상, 충임실조
증상	유방종괴, 不痛,不痒,不赤,內熱,夜熱,五心煩熱,肢體倦瘦,月經不調
치법	[기본] 소기행혈 (초기) 간기울결 → 소기행혈 소간해울 (후기) 기혈휴손 → 대보기혈
변증	간울기체, 간신음허, 어독내독
단미처방	황금, 반지련, 봉독약침액, 유근피, 천련자, 삼릉, 현호색, 조각자, 길경, 오가피
처방	항암단, 가미쌍화탕, 청간해울탕, 귀출파징탕, 활락효령단, 익기양영탕, 굴핵산변 방, 사물탕가미

※ 교과서 외 참고처방

- 유옹·이암(妳巖)·유암 초기 → 십육미유기음
 - 유방암 수술 이후에 수술부위 회복에 도움 →
- 항기 의이인 백편두(초) 30g 길경10g 삼칠분1.5g

제 5절. 유벽

1. 개술

정의	유방에 나타난 다양한 형태, 크기, 수량의 종괴 (유속, 내벽이라고도 하며, 유종결핵의 일종)
증상	월경 전 유창(乳脹)이 나타나는 경우 많음 + 불임증, 월경부조, 갱년기증후군
병인병기	간울기체, 담기응결, 간울신허

※ 섬유샘종(교과서)

- 유벽은 서양의학의 섬유낭종성 변화와 섬유선종을 포괄
- 섬유선종 : 잘 움직이는 덩어리, 외관상 주위의 유방조직에 고정 X
: 20대 여성에서 흔하나 60대에서도 나타남
- 섬유낭종성 변화 : 매우 흔하며, 낭종은 소관분지 및 선지가 확장된 것
↳ 폐경기 전 여성의 60%를 차지한다.

2. 진단과 감별진단

1) 진단

임상표현	유방종괴는 자신이 무의식적으로 촉진하게 되어 내원하는 경우가 많음
통증	자각적인 통증을 동반하지 않는 경우가 더 많음
종괴양상	다발성 / 구슬 켜 모양 / 결절상 / 일측성or양측성 / 종괴의 증대는 완만 외상방 부위 다발 / 드물게 유두의 분비
검사	신체검사로 촉진 → 이상여부 확인 → 유방촬영술 or 조직 검사 → 유방암 감별

2) 감별진단

- 經前乳脹(경전유창) 및 유방암과 감별

└ 월경전 증후군

└ 경전유창은 월경 전 수 일 동안 창통, 유방종괴는 없고 양초경

3. 변증치료

간을기체	젊은 여성이거나 병정이 비교적 짧은 경우가 많음 종괴가 월경전 후 정서변화에 따라 증대하거나 축소 경전유창, 월경부조, 월경통, 불임증 등을 수반 정신적 긴장, 억압, 가슴답답, 옆구리 통증 등	
	서간이기 활혈산결	소요산 加 울금 굴핵 천련자 계내금 하고초 / 십육미유기음(十六味流氣飲)
담기 응결	유방종괴가 계란형, 단단, 매끄러움, 창통은 명확X 젊은 여성인 경우 많고 월경부조가 나타나기도 함 현훈, 흥민, 담다, 인후부불편감, 식욕부진 등	
	소간건비 화담산결	소요산 합 과루해백반하탕 / 해조옥호탕(海藻玉壺湯) / 청간해울탕
간을 신허	작은 알갱이 형태의 유방종괴를 나타내거나 집단적 괴상 혹은 편평한 모양을 이루기도 함 월경 전에 증대, 월경 불순이나 불임증을 동반 눈빛이 어둡고 허리와 무릎에 힘이 없음	
	서간보신 통락산결	정경탕 加 패모 울금 굴핵 아출 천문동

제 6절. 유육과 비수유기 유즙배출

1. 유육 乳衄

정의	유두에서 혈성의 분비물이 나오는 것
양상	보통 일측성, 양측성도 가능 간혹 출혈, 황색 수양성 분비물이 번갈아 나타나며, 유방종괴를 수반하기도 함
질환	유두종, 유선암, 섬유낭성 변화, 유선관 확장증, 만성 유선염 및 유선 결핵
진단	유방암에 의한 분비는 아닌지 확인
원인	유선암과 함께 관내유두종이 흔한 유육의 원인
병인	肝鬱火化, 肝失藏血, 火灼乳絡, 迫血妄行, 氣虛不能統血
변증	· 간울화화 : 단치소요산 加 초용담, 선학초, 천우슬 └ 선학초 : 상중하초의 지혈목적 · 비위기허 : 귀비탕, 보중익기탕 加 선학초, 감인

2. 비수유기 유즙배출(유읍 乳泣)

원인	HPO축의 기능이상, 뇌하수체 미세선종에 의한 고프로락틴 혈증
치료	소간해울 + 보신
증상	임신기나 수유기에 유즙이 저절로 배출되는 것 최근에는 비수유기 유즙배출도 유읍의 범주로 확대됨
검사	유방에 대한 검진, 혈중 PRL 평가, 혈액검사(갑저 배제), 방사선 검사
변증	· 간경울화 ➡ 단치소요산 가감 └ 흑산치 4.5 조구등 7.5 당귀 백작약 복령 하고초 5 초시호 2.5 맥아 15 초산사 5 생지황 6 · 위기허약 ➡ 귀작육군탕 └ 당귀 백작약 만삼 백출 5 진피 3 자감초 2.5 황기 감실 산사초 모려 6 맥아 15